MOSIGO

신규 사업기획서 · 병원동행 대리 예약 플랫폼

최신 개인 Strategy Case Study 기반으로 새로 작성한 사업기획서

시장·고객 → IT/운영 설계 → 사업모델·손익 → 실행·성과관리

개인 작성 | 실제 계약·매출·운영 검증 전 단계

사업화 제안 요약

자녀 중심 예약 경험을 기존 사업자 제휴로 제한 검증

핵심 고객

부모의 병원 방문을 자녀가 검색·비교·예약하고 진행 상황을 확인하는 이용 상황을 고객 가설로 설정.

초기 진입

매니저를 직접 고용하기보다 기존 동행 공급자와 지역·시간을 제한한 제휴 가능성을 우선 검토.

투자 조건

수요·공급·안전·동의·획득비·지원비를 검증하기 전 확장 및 의료 AI 상용화를 보류.

초기 공급 모형

199건

월 완료 가정

공헌이익

3,700원

제휴형 건당

BEP

1,082건

노동비 포함 월

판단 기준 실제 수요·계약 조건과 단위경제성 확보를 전제로 진행·보류 Gate를 설계합니다.

모든 수치는 가정·합성 분석이며 실제 매출이나 고객 성과가 아닙니다.

조사·구현·개인 분석의 구분

5인 팀 PBL의 조사 성과와 교육 이후 단독 Case Study를 분리

출처·시점	수행·근거	새 사업기획서 활용
교육 당시 5인 팀	경쟁 앱 7종·리뷰 118건 공동 조사, 시장·서비스 가정과 교육용 UI	초기 문제·시장 가설의 근거
교육 후 개인 고도화	예약 소유권, 공유 권한, 상태 복구, Operations 화면	Prototype에 기반한 IT/운영 요구사항
개인 Strategy Case Study	AS-IS/TO-BE, 손익·공급·민감도, Gate·정책·KPI	새로운 사업모델 선택·의사결정

판단 기준 팀 조사 수치와 개인 분석을 분리하고, 원문·수집 기간 미확인 항목을 확정된 시장 사실로 표현하지 않습니다.

시장 문제와 근거

공공 동행서비스 수치는 문제 발견의 참고이며 민간 수요의 증거는 아님

공공 미운영
20/31 시군
2025년 원본 인용

이용 건수
4,237 → 12,802
2023→2025 인용

공공 만족도
4.98/5
표본·원문 미확인

원본 해석

특정 시군의 공공 서비스 운영 범위와 이용 현황에 관한 과거 참고 수치.

추가 검증

민간 공급 부족 여부, 자녀의 실제 지불 의향, 이용 빈도·원문 집계 범위는 별도 확인 필요.

판단 기준 공공 미운영을 민간 서비스 공백이나 MOSIGO 이용자 만족도의 증거로 단정하지 않습니다.

과거 교육 PBL 사업안의 원본 인용값이며 최신 공공 통계로 재검증하지 않았습니다.

고객·이용자·공급자의 과업

예약자와 서비스 이용자의 역할 불일치를 제품 정책에 반영

자녀 · 예약/구매 가설

평일 직접 동행하기 어려운 보호자가 공급 비교·예약·진행 상태 확인을 원할 수 있음.

부모 · 실제 이용자

동행 수용·개인정보 동의·이동 안전·진료 당일 경험을 직접 판단하는 주체.

매니저 · 공급자

가용 시간·지역, 취소·예외 대응, 자격·보험·사고 책임 및 단가가 운영 조건.

과업	제품 가치 가설	확인해야 할 자료
선택·예약	조건·가격 비교 → 대리 신청	선택 이유·지불 의향
동의·상태	부모 동의 → 권한별 상태 공유	동의 수용·정보 이해
재예약	상태·이력 확인 → 반복 예약	실제 반복 수요·공급 가용성

교육용 페르소나와 대화는 실제 고객 인터뷰가 아닌 설계 가설입니다.

TAM·SAM·SOM과 거래액 가정

시장 규모·침투율·수익을 서로 다른 지표로 구분

TAM
약 238만 명
65세 이상 경기도 인구 가정

SAM
약 154만 명
20개 시군 비중 가정

SOM
약 1.5만 명
SAM 약 1% 가정

15,000명 × 연 1.5회 × 40,000원 = **연 거래액 9억 원**

산출 단계	보완·실측 조건
TAM	실제 병원동행 필요율·방문 횟수 확인
SAM	지역·시간·매니저 공급·서비스 대상 제한
SOM	유입·CAC·전환율·공급 처리 한도 함께 반영

판단 기준 9억 원은 거래액 가정이며 실제 매출·수익 또는 달성 가능한 수요 예측치로 제시하지 않습니다.

고객 여정과 운영 경계

예약·공유 Prototype의 참고 범위와 실제 사업 수행을 구분

01	02	03	04	05	06
가족 등록	병원 탐색	매니저 비교	신청·동의	진행 공유	요약·재예약

영역	최신 Case Study 설명	향후 구축·검증
예약·계정·공유	소유권·권한·복구·운영 화면의 구현 참고	개인정보·동의·접근 정책
매니저 현장 운영	Service Blueprint의 목표 흐름	계약·자격·보험·배정·사고 대응
결제·진료 정보·AI	UI 시나리오 또는 후속 검토	실결제·정산·전문가 검토·정확성

판단 기준 의료 AI 요약·실시간 동행·병원 예약·결제 운영을 구현 성과로 확대하지 않습니다.

IT 요구사항·권한·수용 기준

제품 설계를 서비스 정책·예외·운영 책임과 연결

정책·기능	설계 요건	인수 기준 제안
대리 예약·동의	예약자/부모 분리, 필수 동의 확인	누락 시 완료 차단 및 사유 안내
권한·공유	소유자/공유자 분리, 읽기 전용·만료·폐기	비인가 변경·만료 후 접근 거부
상태·복구	재진입·중복 요청·상태 충돌 처리	최신 상태 복구·충돌 안내
운영 예외	취소·배정 변경·사고·연락 실패	담당·안내·종결 기록
정책 개정	위험·고객·비용 영향 검토 후 승인	변경 전후·책임·재점검 이력

판단 기준 실제 회사 규정 제정·법률 검토 완료·상용 운영을 주장하지 않는 개인 설계안입니다.

상품·사업모델 비교

교육 당시 상품 가정과 최신 단위경제성 모델을 분리

모델	가격·수익 가정	핵심 비용·제약
원본 PBL 상품안	건당 3만~5만 원 / 월 8만~12만 원	교육 당시 가정·실거래 아님
최신 Case Study 상품	기본 40,000원 / 차량 45,000원 / 월 3회 99,000원	가격·원가 민감도 검토용
직접 제공형	고객 결제 총액 수익 구조를 조건부 검토	매니저 직접 운영·보험·취소·현장 책임
제휴·중개형	중개 수수료 매출 인식 구조 검토	수수료·결제비·획득비·고객지원

선택 이유

기존 공급을 활용해 고객 과업을 검증할 수 있다는 가설. 운영 책임의 계약상 분담은 별도 확인.

보류 이유

직접형은 공급·현장 안전·고정비 부담이 크고, 현재 실제 견적·계약이 없어 우월성을 확정할 수 없음.

손익 모델·BEP 판단

건당 공헌이익 양수와 사업 전체 흑자는 다른 조건

항목	직접 제공형 · 가정	제휴형 · 가정
상품가	40,000원	40,000원
건당 비용	직접 변동비 30,000원	수수료 20%, 결제 3%, 지원 1,200원, 시스템 100원, 획득비
건당 공헌·잔여액	10,000원 · 추가 비용 전	3,700원/건 · 획득비 포함
비교 고정비	연 1억 원 예시	월 현금 200만 + 노동 기회비용 200만 원
BEP	연 10,000건 · 다른 비용 기준	월 1,082건 · 노동비용 포함

매니저
20명
초기 공급 가정

완료 예약
199건
월 기준 가정

노동비 포함 손익
–326만 3,700원
월 기준 가정

판단 기준 공급 확대 전에 고객 획득비와 고객지원 비용, 계약 수수료를 먼저 확인·개선합니다.

수요·공급의 동시 성립 조건

BEP 달성에는 수요만 아니라 시간·지역별 공급도 필요

최대 처리량
433건/월
20명·주 20시간·회당 4시간

완료 가정
199건/월
가동 65%·경유 80%·취소 10%

BEP 환산 공급
약 109명
생산성 고정 가정

비교	월 완료 건수	공급·비용 시사점
수요 가정	1,875건	연 거래액 9억 원 시나리오
초기 공급	199건	수요 가정 약 10.6%
월 손익분기	1,082건	약 109명 환산
수요 가정 대응	1,875건	약 189명 환산

판단 기준 제휴 파트너의 지역·진료시간·단가·보험·취소 책임을 확인하지 못하면 확대를 보류합니다.

인원·건수는 계절성·증원비·고객지원 증가를 반영하지 않은 비교용 추정입니다.

민감도와 손익 악화 요인

수익성 판단을 수요 감소·획득비 증가·취소율로 검증

가정 변경	월 완료	건당 공헌이익	월 노동비 포함 손익
기준	199건	3,700원	−3,263,700원
경유 80 → 60%	149건	3,700원	−3,448,700원
획득비 3천 → 6천 원	199건	1,900원	−3,621,900원
취소 10 → 20%	177건	3,700원	−3,345,100원

개선 변수

획득 경로 개선, 수수료·결제비 협상, 시간·지역 집중, 취소·지원비 절감.

계산 한계

취소 증가에 따른 추가 환불·사고 지원비는 미반영. 실제 결과는 더 악화될 수 있음.

제휴 중심 진입·검증 Gate

시장·공급·IT 정책을 순차 검증한 뒤 조건부 확장

단계	실행·측정 가설	진입·보류 기준
G0 고객	자녀·부모 과업 관찰, 대체 수단·가격 수용 조사	수요·동의 근거 없으면 보류
G1 공급	가용 지역·시간·수수료·취소·보험 확인	계약·안전 책임 불명확 시 보류
G2 제품	동의·공유·복구·만료·타인 접근 검수	필수 예외 미통과 시 재설계
G3 제한 운영	완료·획득비·지원시간·취소·재예약 측정	양의 공헌이익·공급·BEP 검토

판단 기준 AI 추천·B2B/B2G·지역 확장은 반복 수요·책임·단위경제성 확인 후 별도 의사결정합니다.

실행 계획이며 실제 제휴·고객 실증·예산 승인 완료 성과가 아닙니다.

조건부 중기 로드맵

사업 확장보다 고객·공급·IT 위험 제거를 우선

기간 · 제안	핵심 과제	진행·보류 Gate
0~3개월	고객·부모 동의·매니저 시간/단가·보험 확인	고객·안전·공급 미확인 시 보류
3~6개월	제한 지역 예약·공유·취소·복구·지원비 검증	권한 오류·원가 초과 시 재설계
6~12개월	재예약·공헌이익 확인 후 지역·B2B/B2G·AI 검토	반복 수요·수익성 미확인 시 확대 보류

추진 관리

과제별 책임 제안, 의존성, 검증 자료, 비용, 변경 기록과 다음 점검일 관리.

범위 주의

교육 당시 PBL의 3개월 계획과 별도 개인 로드맵 모두 완료 실적이 아닙니다.

성과관리·월간 의사결정

KPI의 분모·기간을 정의하고 실측/합성 데이터를 구분

지표	산식·측정 원칙
예약 확정률	예약 확정 세션 ÷ 예약 시작 세션; 중복·테스트 제외
동행 완료율	동일 예정 기간 완료 건수 ÷ 예약 확정 건수; 취소 별도
매니저 선택 성공률	조건에 맞는 선택 성공 참가자 ÷ 과업 참가자
90일 내 재예약률	90일 추적 완료 고객을 분모로 재예약 비율 산정
단위경제성	건당 공헌이익·CAC·지원비·공급 경유율·월 BEP

판단 기준 월간 보고는 공급·거래 → 수수료·비용 → 차이 원인 → 수정 전망 → 투자 진행/보류 근거 순으로 제안합니다.

실제 운영 KPI가 아닌 계측 설계입니다. 건강정보·연락처는 분석 이벤트 수집에서 제외합니다.

사업화 최종 판단

기존 사업자 제휴형의 제한 검증을 조건부 우선안으로 제안

> 고객의 실질 과업과 공급·안전·단위경제성을 확인하기 전,
> **대규모 지역 확장과 의료 AI 상용화를 보류한다.**

우선 의사결정	현재 제안	추가 근거
제휴형 우선	기존 동행 사업자 제휴 검증	가용 시간·단가·계약·보험
핵심 IT 범위	대리 예약·동의·권한·복구	과업 관찰·수용 기준
직접형 비교	운영 책임·비용 확보 후 재심사	실제 운영 견적·품질
확대 여부	반복 이용·단위경제성·공급 검증 뒤 판단	실제 데이터·승인 책임

판단 기준 이 문서는 투자·실행의 조건을 제시한 개인 사업기획서이며 영업 계약·매출·수주 성과를 주장하지 않습니다.

출처·가정·미확인 정보

최신 Case Study 중심 신규 문서 · 교육 당시 자료는 원본 인용 근거

최신 작성 기준

MOSIGO Strategy Case Study 9개 장(시장·고객·제품·사업성·실행·KPI·의사결정).

교육 자료 참고

5인 팀 교육 PBL 사업기획서 PC QA 수정본(13쪽). 공공자료·시장·상품·팀 조사 확인용.

항목	검증 한계
조사	앱 7종·리뷰 118건의 원문·수집일·분담 기준 미확인
시장	공공 통계·TAM/SAM/SOM은 당시 인용·추정값이며 최신 원문 재대조 미실시
재무	9억 거래액·월 199건·건당 3,700원·BEP 1,082건은 사업성 모형값
실행	고객 인터뷰·실제 동행·계약·실결제·매출·AI 의료운영 실적 미확인

https://mosigo-case-study.vercel.app/

교육 프로젝트 자료를 참고해 개인 작성한 신규 사업기획서입니다.